

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

Escala Columbia para Evaluar el Riesgo de Suicidio (C-SSRS)

Eje I • Versión de trabajo: 9 de agosto de 2026 • Estado: ficha documental, no manual

1 Identificación

Nombre	Escala Columbia para Evaluar el Riesgo de Suicidio
Sigla	C-SSRS
Autores	Posner, K., et al.
Año	2011
Eje	EJE I – PROBLEMAS, SÍNTOMAS Y RIESGO
Constructo principal	Ideación y Conducta suicida
Población	Todas las edades
Tipo de instrumento	Entrevista estructurada clínica o autoinforme
Disponibilidad en español	Sí
Acceso/licencia	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Nota curatorial de derechos	No alterar contenido clínico; mantener copyright.

2 Fundamentación conceptual

Constructo evaluado: Ideación y Conducta suicida. La descripción procede del catálogo maestro y debe contrastarse con la fuente original antes de emplearla para decisiones clínicas o de investigación.

Dominio conceptual	Problemas, Síntomas y Riesgo (General)
Dimensiones declaradas	2 áreas primarias (Ideación Suicida y Comportamiento Suicida).

3 Características generales

Formato	Entrevista estructurada clínica o autoinforme
Población objetivo	Todas las edades
Número de ítems	Hasta 10 ítems núcleo según las respuestas de cribado (formato escalonado).
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Formato de respuesta	Dicotómicos (Sí/No) para presencia, con subpreguntas tipo Likert para intensidad.
Administración	No verificado en una fuente primaria dentro de la biblioteca; consultar manual o protocolo oficial.
Tiempo estimado	No verificado en las fuentes disponibles.

4 Estructura

Dimensiones/subescalas	2 áreas primarias (Ideación Suicida y Comportamiento Suicida).
Ítems	Hasta 10 ítems núcleo según las respuestas de cribado (formato escalonado).
Control curatorial de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Respuesta	Dicotómicos (Sí/No) para presencia, con subpreguntas tipo Likert para intensidad.
Relación ítem-dimensión	No verificada de forma exhaustiva; no reconstruirla sin manual o publicación primaria.
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.

5 Sistema de puntuación

Severidad de la ideación de 1 a 5 (categorial-ordinal).

Regla de corrección	Severidad de la ideación de 1 a 5 (categorial-ordinal).
Ítems invertidos	No verificado en las fuentes disponibles.
Baremos	No verificado en una fuente normativa autorizada.
Control de versión	No aplicar reglas de otra edición, forma breve, traducción o población.

6 Interpretación

Puntuación 4 o 5 (Ideación con intención, o con intención y plan) o cualquier comportamiento suicida activa protocolos de intervención y emergencia inminente.

Los puntos de corte y baremos deben confirmarse en la versión, población y país pertinentes. No se recomienda transformar estas notas en diagnóstico ni usar cifras no verificadas.

7 Evidencia psicométrica

Es el Gold Standard mundial actual impulsado por la FDA. Evalúa ideación, intensidad y comportamiento suicida.

Consistencia interna	No desagregada en el catálogo; consultar los estudios citados.
Validez	Es el Gold Standard mundial actual impulsado por la FDA. Evalúa ideación, intensidad y comportamiento suicida.
Fiabilidad temporal	No verificado en las fuentes disponibles.
Muestra y contexto	No verificado de forma suficiente para generalización.

8 Adaptaciones

Español	Sí
Versión/cantidad curada	No fijado en el ledger estructurado.
Versión exacta	Ledger curado disponible con 5 enlace(s); comprobar versión y permiso antes de aplicar.
Población/país	Todas las edades
Alerta de versión	Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
Advertencia	Una traducción, forma breve o revisión no es intercambiable con la edición original sin evidencia de equivalencia.

9 Aplicaciones

- Evaluación del constructo Ideación y Conducta suicida en Todas las edades, condicionada a la validez de la versión seleccionada.
- Uso docente o de investigación únicamente cuando lo permitan la licencia, el consentimiento y la cualificación del usuario.
- Uso clínico solo como parte de una evaluación multimétodo; no reemplaza entrevista, juicio profesional ni análisis de riesgo.

10 Fortalezas

- El catálogo identifica autores, año y constructo: Posner, K., et al.; 2011.
- Disponibilidad española reportada: Sí
- Trazabilidad local: 6 archivo(s) técnicamente legible(s) y 2 PDF web verificado(s).

11 Limitaciones

- Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
- Fijar edición, idioma, longitud, población y reglas antes de aplicar.
- Archivos locales aislados por formato inválido: 0.
- Los datos del maestro pueden contener referencias, versiones o puntos de corte preliminares; prevalece la fuente primaria.
- No se incluyen ítems, instrucciones, claves o baremos cuando su reproducción no está autorizada o no pudo verificarse.

12 Consideraciones éticas

- Obtener consentimiento informado, proteger la confidencialidad y limitar el acceso a resultados.
- Usar profesionales con formación suficiente y documentar versión, idioma, población, fecha y condiciones de administración.
- No emplear la escala como único fundamento de diagnóstico, exclusión, selección o intervención.
- Respetar derechos de autor, licencias, restricciones territoriales y prohibiciones de modificación o redistribución.
- Ante riesgo agudo o hallazgos críticos, seguir protocolos clínicos y legales aplicables; la ficha no sustituye procedimientos de seguridad.

13 Síntesis técnica

Constructo	Ideación y Conducta suicida
Población	Todas las edades
Estructura	Catálogo: Hasta 10 ítems núcleo según las respuestas de cribado (formato escalonado).; 2 áreas primarias (Ideación Suicida y Comportamiento Suicida).. Control curado: No fijado en el ledger estructurado.
Puntuación	Severidad de la ideación de 1 a 5 (categorial-ordinal).
Interpretación	Puntuación 4 o 5 (Ideación con intención, o con intención y plan) o cualquier comportamiento suicida activa protocolos de intervención y emergencia inminente.
Estado de fuentes	Locales válidos: 6; web PDF: 2; aislados: 0.
Estado de uso	Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir.
Decisión técnica	Ficha documental disponible. La aptitud clínica requiere protocolo autorizado, versión fijada y verificación por profesional competente.

14 Referencias APA 7

Posner, K., et al. (2011). Escala Columbia para Evaluar el Riesgo de Suicidio.

Fuente de referencia del catálogo: [Columbia Lighthouse Project](<https://cssrs.columbia.edu/>)

<https://cssrs.columbia.edu/the-columbia-scale-c-ssrs/translations/>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3893686/>

<https://cssrs.columbia.edu/wp-content/uploads/C-SSRS-Lifetime-Recent-US-spanish-5.1-2026.pdf>

<https://cssrs.columbia.edu/wp-content/uploads/C-SSRS-Screener-since-last-visit-US-Spanish-2026.pdf>

<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3893686/pdf/nihms511139.pdf>

Nota de control: las URLs se conservan para trazabilidad; cada publicación mantiene sus propios derechos y condiciones de uso.

Verificación técnica y trazabilidad — revisión 2026-08-10

Esta sección prevalece sobre datos anteriores cuando existe conflicto. Se cotejó el activo local y se usaron únicamente fuentes identificables. 'No verificado' significa que no se encontró evidencia suficiente; no es una inferencia ni una reconstrucción.

1. Versión exacta y activo cotejado	C-SSRS española, forma extensa con secciones de ideación, intensidad y conducta; no reducir a un conteo único de ítems. Activo cotejado: Protocolo.pdf, SHA-256 e988 346fe68 582b7351ab6448c9eba73 114f3c68c769dd963ab62a290d 83e2f6.
2. Población e informante	Ficha previa: Todas las edades. Confirmar límites etarios, contexto e informante en el manual de la versión exacta.
3. Administración	Entrevista estructurada por personal capacitado.
4. Tiempo de aplicación	NO VERIFICADO: el formulario no informa una duración y no se localizó una fuente primaria específica de esta forma.
5. Estructura e ítems reales	C-SSRS española, forma extensa con secciones de ideación, intensidad y conducta; no reducir a un conteo único de ítems.
6. Periodo temporal	Vida y último mes en el activo local, según sección.
7. Escala/formato de respuesta	Sí/No más escalas de intensidad y campos de conducta.
8. Algoritmo de puntuación	No usar suma global. Registrar la categoría más grave de ideación (1–5), intensidad y presencia/tipo/recencia de conducta según la forma. La decisión clínica se basa en respuestas y algoritmo de triaje de la forma concreta.
9. Manejo de omisiones	NO VERIFICADO: no se encontró una regla explícita y legítima para datos faltantes de la versión exacta. No imputar ni prorratear sin manual.
10. Psicometría específica español/LatAm	NO VERIFICADO de forma específica para esta versión, idioma y población española/latinoamericana. La mera existencia de estudios o de una traducción no acredita equivalencia.
11. Baremos, cortes e interpretación	Puntuación 4 o 5 (Ideación con intención, o con intención y plan) o cualquier comportamiento suicida activa protocolos de intervención y emergencia inminente. Usar solo si coincide con la versión/población citada; no se asume universalidad.
12. Licencia, uso y redistribución	Estado conservador: Restringido, licenciado o sujeto a permiso; revisar condiciones del titular antes de usar o redistribuir. No redistribuir/modificar hasta documentar titular y permiso de la versión exacta.
13. Referencias y fuentes verificadas	Columbia Lighthouse Project, https://cssrs.columbia.edu/ . Debe identificarse por nombre y fecha de la forma concreta; no existe un único algoritmo sumatorio para todas las formas.
14. Decisión de QA	PARCIALMENTE COTEJADO: estructura visible contrastada con Protocolo.pdf. Los campos marcados NO VERIFICADO siguen bloqueando una declaración de completitud clínica.